

9A. Sacroilíacas: anamnesis dirigida

La anamnesis aumenta o reduce plausibilidad, pero no confirma la sacroilíaca sin exploración concordante.

Pregunta literal	Si responde SÍ → orienta	Si responde NO → aporta	Qué explorar después
¿Puede señalar con un dedo el dolor justo por debajo y medial a la EIPS?	Fortin positivo: aumenta plausibilidad del complejo SI.	Hace SI menos probable.	Repetir localización y clúster de provocación.
¿Empeora al levantarse, girarse en la cama, subir escaleras o apoyar una sola pierna?	Carga sacroilíaca/posterior.	Reduce patrón mecánico SI.	Distraction, thigh thrust, compression, sacral thrust y Gaenslen.
¿Empezó durante embarazo/postparto, tras trauma o después de una fusión lumbar?	Contexto que aumenta plausibilidad SI.	Reduce esos factores contextuales, no SI.	Estabilidad pélvica, discrepancia, marcha y antecedentes quirúrgicos.
¿El dolor está en la ingle o en el lateral al acostarse sobre ese lado?	Cadera intraarticular o GTPS como imitadores.	Reduce esos imitadores.	Rotación interna/FADIR o palpación GT/abducción resistida.
¿Baja por la pierna con hormigueo, pérdida de fuerza o cambia al mover la espalda?	Origen lumbar/radicular.	Reduce radiculopatía, no dolor referido.	SLR/slump, neurología y movimientos lumbares.
¿Tiene rigidez matutina prolongada, dolor nocturno que mejora al levantarse, psoriasis o uveítis?	Patrón inflamatorio/espondiloartritis.	Reduce patrón inflamatorio.	Cribado reumatológico, analítica/imágenes y derivación según contexto.

SÍNTESIS DE ANAMNESIS

Una localización Fortin y un patrón de carga aumentan sospecha; varias pruebas de provocación negativas ayudan más a descartarla que varias positivas a confirmarla.

9B. Sacroilíacas: exploración esencial guiada

Un test solo se considera positivo si reproduce el dolor o el síntoma habitual en la localización esperada. Comparar lados cuando sea apropiado y no diagnosticar por una maniobra aislada.

Test	Cómo se hace	Positivo → qué implica	Negativo → qué implica
Fortin finger	Pedir que señale con un dedo el punto máximo de dolor; repetir para confirmar localización.	Punto repetido inmediatamente inferomedial a EIPS: aumenta plausibilidad del complejo SI.	Hace SI menos probable, pero no la excluye; revisar lumbar, cadera y glúteo.
Distraction	Supino; aplicar presión posterolateral sostenida sobre ambas EIAS.	Reproduce dolor posterior habitual: prueba de provocación SI concordante.	Una negativa aislada no excluye; cuenta dentro del clúster.
Thigh thrust	Supino; cadera flexionada 90°, estabilizar sacro y aplicar fuerza axial por el fémur.	Reproduce dolor habitual posterior: apoya SI y suele ser una de las maniobras más útiles.	Reduce algo probabilidad; no excluye por sí sola.
Compression	Decúbito lateral sobre lado asintomático; comprimir cresta ilíaca superior hacia camilla.	Reproduce dolor SI posterior habitual: prueba concordante.	Negativa aislada no excluye; integrar con las demás.
Sacral thrust	Prono; aplicar presión anterior sostenida sobre centro del sacro.	Reproduce dolor habitual SI/posterior: suma al clúster.	No excluye; puede ser negativa aunque otras sean positivas.
Gaenslen	Supino al borde: una cadera en flexión máxima y la otra extendida; aplicar torsión suave.	Dolor posterior habitual en el lado evaluado: suma al clúster; localizar el dolor.	No excluye y puede provocar cadera/lumbar; interpretar con cautela.

SÍNTESIS CLÍNICA

Interpretar el conjunto, no cada prueba: varias pruebas negativas hacen menos probable que la SI sea el generador. Tres o más positivas concordantes elevan la sospecha, pero el valor confirmatorio es limitado; si la decisión es intervencionista, usar bloqueo diagnóstico con tarea funcional.

9C. Sacroilíacas: bloqueos, radiofrecuencia y plan

No existe una plantilla ecográfica diagnóstica de SI normal. La ecografía aporta sonoanatomía y guía; la confirmación intraarticular exige control apropiado.

Ecografía procedural	Documentar
Landmarks	Sacro, ilion, EIPS, forámenes sacros y porción posterior accesible de la articulación.
Seguridad	Vasos con Doppler, profundidad, trayecto, punta de aguja y fármaco/volumen.
Limitación	La guía ecográfica no siempre confirma distribución intraarticular; seguir protocolo local de imagen/contraste cuando el objetivo lo requiera.

Escenario	Intervención	Cómo decidir
Sospecha intraarticular	Bloqueo con anestésico local, pequeño volumen y prueba funcional antes/después; corticoide solo si indicación terapéutica.	Las infiltraciones IA tienen validez diagnóstica para dolor intraarticular, no para todo el complejo posterior.
Dolor posterior persistente	Bloqueos de ramas laterales como prueba pronóstica y RF en paciente seleccionado.	Usar criterios y técnica del protocolo; no indicar por exploración o RM aislada.
Fracaso conservador	Revisar diagnóstico, rehabilitación y comorbilidades; fusión solo en casos estrictamente seleccionados.	No escalar si el bloqueo no cambia el dolor habitual o la tarea provocadora.

PLAN BASE	Educación, estabilización lumbopélvica, fuerza de cadera, marcha y control de cargas 6-12 semanas; cinturón pélvico en casos seleccionados, sobre todo periparto. Tratar factores de sueño, miedo y desacondicionamiento.
-----------	---

MENSAJE AL PACIENTE	El bloqueo es una prueba y, a veces, un tratamiento temporal. Si no cambia su dolor habitual al hacer la tarea que lo provoca, repetiremos la valoración en vez de insistir sobre la sacroilíaca.
---------------------	---

9D. Sacroilíacas: pauta práctica

Dosis orientativas para adulto no frágil. Individualizar por edad, peso, embarazo, alergias, función renal/hepática, riesgo GI/CV, anticoagulación y medicación concomitante.

CÓMO PRESCRIBIR

Elegir una sola estrategia analgésica principal, fijar fecha de fin y revisar una tarea funcional.
Paracetamol: máximo conservador 3 g/día. No combinar AINE. En paciente de riesgo GI que precise AINE, valorar omeprazol 20 mg/día durante el curso.

Cuadro	Fármaco • dosis	Duración / revisión
Dolor mecánico	Ibuprofeno 400 mg/8 h O naproxeno 250-500 mg/12 h si es seguro.	5-7 días junto a movimiento y estabilización.
Rescate	Paracetamol 500-1.000 mg/8 h si precisa (máx. 3 g/día).	3-5 días.
Patrón inflamatorio	No pautar solo analgesia repetida: solicitar estudio y derivación reumatológica según contexto.	Prioridad según síntomas sistémicos y actividad inflamatoria.

Bloqueo / técnica	Fármaco propuesto	Volumen y guardarraíl
Diagnóstico intraarticular	Lidocaína 1-2% o bupivacaína 0,25-0,5%; sin corticoide.	Total 1-2 mL; pequeño volumen y tarea antes/después.
Terapéutico IA	Betametasona depot 0,5-1 mL o triamcinolona 20-40 mg + anestésico local.	Total 1,5-2,5 mL; confirmar distribución intraarticular.
Ramas laterales	Lidocaína 1-2% o bupivacaína 0,25-0,5%; sin corticoide.	0,3-0,5 mL por diana; prueba pronóstica antes de RF.
RF ramas laterales	Lidocaína 1% cutánea; lidocaína 2% 0,5-1 mL por diana antes de lesión.	Sin corticoide rutinario; parámetros y número de lesiones según protocolo.

REHABILITACIÓN

Estabilización lumbopélvica, fuerza de cadera, marcha y control de carga 6-12 semanas; cinturón pélvico seleccionado, especialmente periparto.

EVITAR

Usar una imagen degenerativa como diagnóstico, sobrepasar la pequeña capacidad articular, RF sin bloqueo pronóstico o repetir infiltración cuando no cambia el dolor habitual.